

Lavagem Nasal

Otite e Sinusite

Congestão Nasal

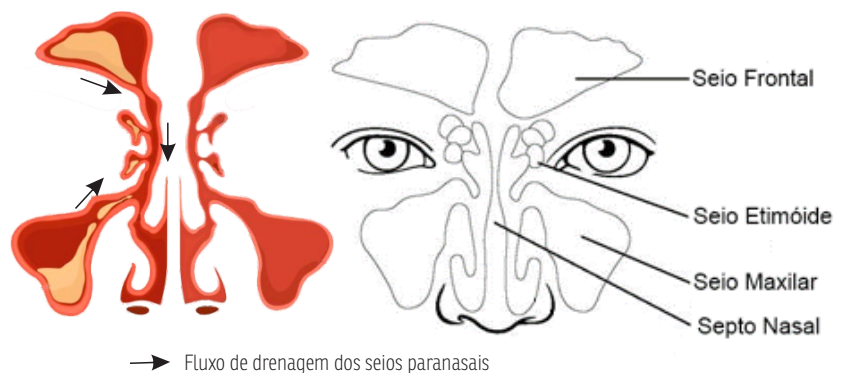
A congestão nasal, popularmente conhecida como nariz entupido, é um desconforto freqüente nas crianças e uma preocupação para seus cuidadores. O nariz congestionado atrapalha a respiração, interferindo na qualidade do sono e na alimentação do bebê, principalmente na hora de mamar.

A obstrução nasal é uma condição que pode ser observada em qualquer época do ano. Porém, essa é mais freqüência no outono e no inverno, já que são estações em que há maior ocorrência de quadros gripais e infecções do trato respiratório.

As fossas nasais e os seios paranasais são responsáveis pela **filtração, aquecimento e umidificação do ar inspirado**, deixando-o em condições favoráveis para a troca gasosa nos pulmões.

Formação dos Seios Paranasais

Os seios paranasais iniciam seu desenvolvimento antes do nascimento e atingem sua conformação final por volta dos 7 anos de idade.



	Idade Gestacional em que começa a formação (em meses)	Idade em que a presença tem Significado Clínico	Completamente desenvolvido
Maxilar	2	Ao Nascimento	12 anos
Esfenoide	3	Ao Nascimento	12 anos
Frontal	4	3 anos	18-20 anos
Etmóide	3	8 anos	12-15 anos

Tanto a mucosa nasal quanto a dos seios paranasais são recobertas por uma camada de células produtoras de muco (catarro). Além destas células existem também as células ciliadas responsáveis por remover o excesso de muco dos seios paranasais para as fossas nasais e daí para a rinofaringe.

Os cílios respiratórios batem aproximadamente mil vezes por minuto, isso significa que os materiais da superfície são movidos numa proporção de 3 a 25 mm por minuto. A temperatura ideal para o bom funcionamento das células ciliadas é de 33°C, sendo que o batimento ciliar diminui quando a temperatura está abaixo de 18°C ou acima de 40°C. O pH ideal deve estar entre 7 e 8.

Algumas condições reduzem o volume e alteram a viscosidade do muco:



Infecções



Desidratação



Medicamentos



O acúmulo de muco nos seios paranasais é responsável pelos quadros de **sinusite**. Este muco também pode alcançar os ouvidos por meio da Tuba de Eustáquio causando **otites médias**.

Como ajudar as crianças com Obstrução Nasal?

A literatura médica aprova e incentiva a aplicação de Soro Fisiológico para o tratamento da Obstrução Nasal.

O EPOS 2012: **European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012** afirma que esta aplicação deve ser realizada na posição sentada ou de pé com a cabeça levemente reclinada para frente.

Num estudo de 2015 os autores afirmam que *a irrigação nasal com solução fisiológica possui benefícios para alívio dos sintomas de IVAs. Entretanto, os estudos incluídos foram pequenos e possuem alto risco de viés, reduzindo a confiança dos resultados.*

Efeitos adversos leves não foram incomuns e 40% a 44% dos bebês apresentaram dificuldade com a aplicação da solução. Este desconforto teve mais associação com a pressão aplicada do que pelo soro em si.

Ainda num estudo de 2016 os autores afirmam: *Irrigação nasal realizada sob baixa pressão deve ser realizada com dispositivos de baixa pressão.*

Outra metanálise de 2018 diz que *a irrigação com solução salina pode reduzir a severidade dos sintomas relatados pelos pacientes (tanto crianças quanto adultos), com rinite alérgica, sem grandes efeitos adversos. [...] A qualidade da evidência apresentada foi baixa ou muito baixa. Os estudos incluídos na pesquisa eram pequenos e não avaliaram os desfechos de maneira uniforme. Esta revisão também não inclui a comparação entre volumes e tonicidade da solução empregada.*

Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, Bachert C, Alobid I, Baroody F, Cohen N, Cervin A, Douglas R, Gevaert P, Georgalas C, Goossens H, Harvey R, Hellings P, Hopkins C, Jones N, Joos G, Kalogjera L, Kern B, Kowalski M, Price D, Riechelmann H, Schlosser R, Senior B, Thomas M, Toskala E, Voegels R, Wang de Y, Wormald PJ. **EPOS 2012: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists.** Rhinology. 2012 Mar;50(1):1-12. doi: 10.4193/Rhino12.000. PMID: 22469599.

Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections

David King Ben Mitchell Christopher P Williams Geoffrey KP Spurling. Version published: 20 April 2015

Saline irrigation for chronic rhinosinusitis

Lee Yee Chong Karen Head Claire Hopkins Carl Philpott Simon Glew Glenis Scadding Martin J Burton Anne GM Schilder Authors' declarations of interest. Version published: 26 April 2016

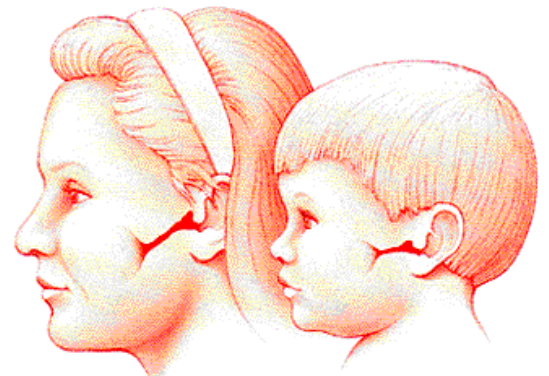
Saline irrigation for allergic rhinitis

Karen Head Kornkiat Snidvongs Simon Glew Glenis Scadding Anne GM Schilder Carl Philpott Claire Hopkins. 22 June 2018

Por que as crianças sofrem tanto com otite e sinusite?

Nas crianças a Tuba de Eustáquio (que fica na parte de trás da cavidade nasal) é mais horizontalizada. Esta situação anatômica favorece a aspiração de pequenas quantidades de muco da cavidade nasal que podem levar vírus e bactérias até o ouvido médio.

Outra peculiaridade diz respeito à anatomia do seio maxilar. A drenagem deste seio ocorre em sentido anti-gravitacional



Mamar deitado e o risco de Otite

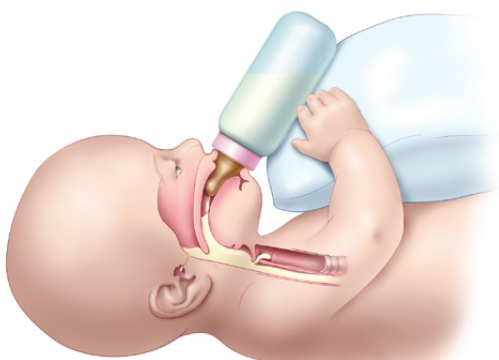
Na **amamentação**, a sucção faz com que a mandíbula do bebê se projete para frente e mantém a tuba auditiva fechada. Quanto mais força o bebê faz para mamar (no seio), menor é a chance da tuba permitir a passagem do líquido.

A pressão provocada pela sucção da amamentação é diferente da exercida pela **mamadeira**. Com a mamadeira, o bebê não faz nenhum esforço para a saída do líquido e a musculatura do canal auditivo fica mais "frouxa". O leite consegue passar e atinge a tuba auditiva, podendo causar a otite.

Portanto, **amamentar deitada não causa otite**. Mas se o seu bebê mama na mamadeira, tenha o cuidado de colocá-lo em uma posição mais verticalizada. Essa recomendação também é válida para os bebês com histórico de refluxo.

Sobre mamar deitado, vamos esclarecer algumas coisas:

1. Bebês em aleitamento materno podem mamar deitados sem nenhum problema
2. Bebês que usam mamadeira não devem mamar deitados. O bico do mamilo, pela sua elasticidade e moldagem, toca em uma região da cavidade oral onde há contração dos músculos do palato e consequente proteção do ouvido durante a sucção. Já o bico da mamadeira, como é mais curto e não se molda à sucção, não promove estímulo à musculatura do palato, causando desequilíbrio de pressões durante a sucção e risco aumentado para otites.
3. Essa é uma posição muito utilizada pois a mãe fica confortável e relaxada. Ela deve estar deitada de lado e o bebê de frente para ela, barriga com barriga.
4. Caso o bebê tenha refluxo, o recomendado é elevar a cabeça do bebê com um travesseiro. O leite materno tem propriedades



Incorreto



Correto

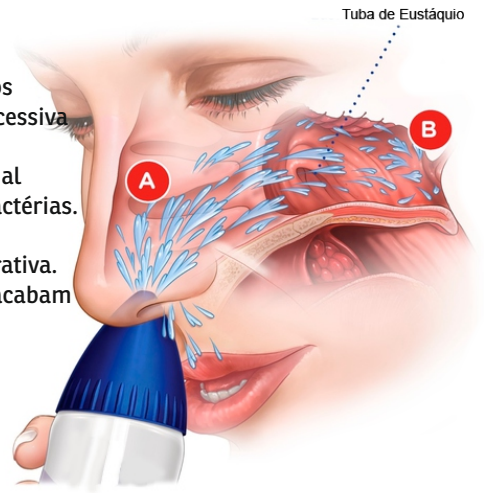
Aplicação de Soro Nasal

As evidências científicas reconhecem a importância da aplicação do Soro Fisiológico nasal nos quadros de Obstrução Nasal. No entanto é importante ter cuidado de não exercer pressão excessiva durante o procedimento para evitar que o soro penetre na tuba auditiva e chegue ao ouvido. Além disso, bom lembrar que a drenagem do seio maxilar ocorre em sentido anti-gravitacional favorecendo a permanência de um resíduo que pode servir de meio de cultura para vírus e bactérias.

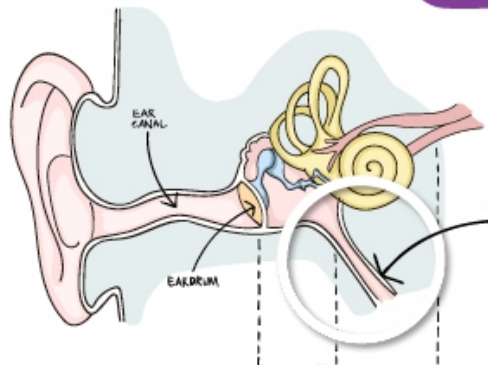
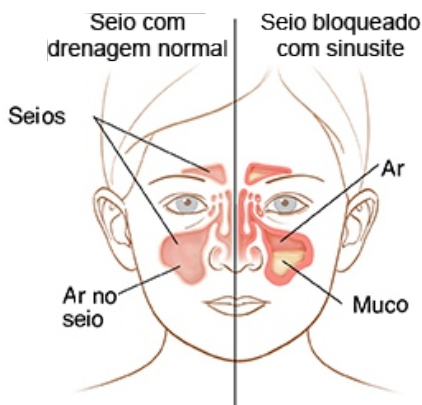
Apesar de todos os benefícios do procedimento, nem sempre a criança vai se mostrar colaborativa. Muitas crianças choram e, os pais desesperados, na ânsia de terminar logo o procedimento, acabam exercendo muita força e pressão no dispositivo.



Aplique o soro com a criança sentada ou de pé, com a cabeça reclinada para frente. Os bebês podem fazer o procedimento deitados.

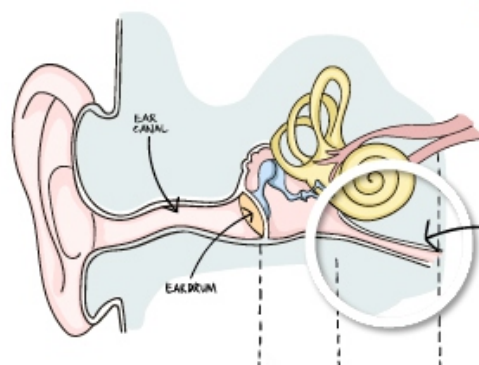


- Os dispositivos em **spray e jato contínuo** são mais seguros para aplicar um **alto volume com baixa pressão**.
- **O catarro precisa sair pela outra narina?** Definitivamente NÃO. Quando aplicado sob baixa pressão e alto volume a maior parte do catarro sai pela mesma narina ou cai na rinofaringe sendo posteriormente deglutido pelo bebê e eliminado nas fezes.
- Nas seringas e garrafinhas a pressão exercida pode levar o muco contaminado para os seios paranasais e ouvido médio.
- Os dispositivos de aspiração nasal podem machucar a mucosa nasal, causar sangramento e causar ainda mais apreensão!



MINHA TUBA DE EUSTÁQUIO É MAIS ANGULADA E PERMITE UMA DRENAGEM MAIS FÁCIL. POR ISTO EU TENHO MENOS OTITES.

TUBA DE EUSTÁQUIO



MINHA TUBA DE EUSTÁQUIO É MAIS RETA E DIFICULTA A DRENAGEM. POR ISTO EU TENHO MAIS OTITES.

TUBA DE EUSTÁQUIO

